# Nová multidisciplinárna CKM stratégia (AHA/ACC/ADA/ASN, 2026): prvá smernica pre kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 16.06.2026




Ilustračná scéna: štyri odbornosti po prvý raz hovoria jedným hlasom.

Dňa 9. júna 2026 organizácie AHA, ACC, ADA a ASN spoločne zverejnili prvú multidisciplinárnu smernicu zameranú na kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm (*cardiovascular-kidney-metabolic*, CKM). Dokument podľa formulácie autorov pôvodný rámec z roku 2013 „uzatvára, nahrádza a rozširuje“. Predovšetkým však presadzuje koncepciu, že **obezita, diabetes 2. typu, chronická choroba obličiek (CKD) a kardiovaskulárne ochorenia sú prepojené ako jeden kontinuálny syndróm**.

## Čo je nové v praxi

### 1) Štandardizovaná klasifikácia štádií CKM (0 až 4)

Smernica zavádza **klasifikáciu štádií CKM od 0 do 4**. Cieľom je identifikovať pacientov skôr, voliť terapie podľa **absolútneho kardiovaskulárneho rizika** a hodnotiť cielené intervencie aj podľa toho, či spomalia alebo zvrátia progresiu do CKD a kardiovaskulárneho ochorenia (CVD).

### 2) Riziko kvantifikovať jednotným nástrojom: PREVENT

Pre pacientov v štádiách CKM 0 až 3 sa odporúča používať rovnice **PREVENT** na odhad **10- a 30-ročného** rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia (ASCVD), srdcového zlyhania a celkového kardiovaskulárneho rizika. Výsledok má pomôcť určiť intenzitu preventívnej liečby.

### 3) Rutinné vyhľadávanie CKD: eGFR + UACR

Pri skríningu sa majú pravidelne používať:

- **eGFR** – odhadovaná glomerulová filtrácia (filtračná funkcia obličiek),

- **UACR** – pomer albumín/kreatinín v moči (marker renálneho aj kardiovaskulárneho rizika).

CKD sa teda nemá diagnostikovať až dodatočne, ale aktívne vyhľadávať a riziko včas stratifikovať.

### 4) Inhibítory SGLT2 a liečba na báze GLP-1 ako kľúčové CKM terapie

Dôraz sa kladie na terapie, ktoré majú súčasne **kardiovaskulárny aj renálny prínos**, nielen glykemický účinok. Výslovne sa uvádzajú:

- **inhibítory SGLT2**,
- **terapie na báze GLP-1**.

### 5) Interdisciplinárny manažment a koordinátor starostlivosti

Smernica odporúča koordinovaný prístup naprieč špecializáciami (všeobecný lekár, kardiológ, nefrológ, diabetológ) a zavádza princíp **zodpovednej kontaktnej osoby** alebo koordinátora starostlivosti, aby sa liečba skutočne zavádzala dôsledne a jednotne.

### 6) Obezita nie je doplnok, ale základ

Pacient sa má hodnotiť nielen podľa BMI, ale aj podľa **obvodu pása**. Liečba vychádza z toho, že nadmerné množstvo tukového tkaniva je hlavným hnacím mechanizmom progresie CKM syndrómu. U vhodných pacientov sa zvažujú aj **lieky proti obezite** a **metabolická (bariatrická) chirurgia**.

### 7) Sociálne determinanty zdravia ako súčasť klinickej praxe

Zmyslom nie je len „spomenúť“ sociálne faktory, ale **systematicky ich zisťovať** a riešiť prekážky ako:

- nedostatočná dostupnosť potravín,
- bariéry v prístupe k liečbe,
- nestabilné bývanie,
- doprava,
- a ďalšie socioekonomické obmedzenia.

## Desať odporúčaní v skratke

Odporúčania smernice pokrývajú najmä tieto okruhy:

- rutinná klasifikácia štádií CKM,
- kvantifikácia kardiovaskulárneho rizika pomocou nástroja PREVENT,
- pravidelný skríning CKM rizík (vrátane cieľových stavov ako pre-heart failure, MASLD a obštrukčné spánkové apnoe – OSA),
- zahrnutie sociálnych determinantov zdravia do manažmentu,
- interdisciplinárna starostlivosť,
- obezita ako základná liečebná os,
- diabetologická liečba s prednosťou liekov s CKM prínosom (inhibítory SGLT2, GLP-1),
- aktívne identifikovanie a liečba CKD (eGFR + UACR, blokáda RAAS, inhibítory SGLT2 a pri pretrvávajúcej albuminúrii aj ďalšie triedy ako nesteroidové antagonisty mineralokortikoidných receptorov (nsMRA) alebo GLP-1 podľa kontextu),
- u pacientov s už prítomným ASCVD intenzívny CKM manažment,
- pri srdcovom zlyhaní integrácia CKM prospešných terapií podľa fenotypu (inhibítory SGLT2, inhibítory RAAS, MRA, GLP-1 podľa vhodnosti).

## Prepojenie s nefrológiou a dialyzačnou realitou

V nefrologickej praxi smernica posúva uvažovanie od „oblička je dôsledok“ k „oblička je centrálna súčasť syndrómu“:

- albuminúria a eGFR sa majú používať rutinne,
- liečba sa má voliť podľa renálneho aj kardiovaskulárneho dosahu,

- a konať sa má už v preventívnej fáze, nie až pri zjavnej progresii.

---

***Zdroj:*** *MedCentral (súhrnný článok o vydaní smernice AHA/ACC/ADA/ASN, 2026): „AHA, ACC Issue First-Ever Multi-Society CKM Guidance“. Link na zdroj.*

---

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ckm-syndrom-prva-multidisciplinarna-smernica-2026 · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.